PROFESIONAL

EJE 1 · TRANSFORMACIONES DEL CUIDADO Y HUMANIZACIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS ALFREDO LANARI
Universidad de Buenos Aires

QUE EL CUIDADO TAMBIÉN NOS ALCANCE

Lic. Curletti, Sabrina Soledad[1] · Lic. Domecq, Celeste[2]

[1] Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari · [2] Facultad de Medicina, UBA

1 INTRODUCCIÓN

El trabajo de enfermería implica alta carga emocional, comunicación bajo presión y cuidados complejos. La OMS y la OIT (2022) advierten que los riesgos laborales afectan el bienestar del personal y la seguridad asistencial. Goleman (1995) describe cinco competencias: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Su desarrollo podría favorecer los vínculos y el manejo del estrés, pero no sustituye condiciones laborales seguras. Esta revisión analiza críticamente la evidencia sobre inteligencia emocional, comunicación y estrés, considerando también el apoyo institucional.

2 OBJETIVOS

General: analizar la relación entre desarrollo de inteligencia emocional, vínculos humanos y estrés laboral en enfermería.

Específicos: describir las competencias propuestas por Goleman; examinar estudios sobre comunicación, vínculos y estrés; proponer estrategias personales e institucionales para el bienestar.

3 METODOLOGÍA

Diseño: revisión bibliográfica narrativa, no sistemática.

Fuentes y período: documentos OMS/OIT (2022), The Joint Commission (2019), Goleman (1995, 1998) y publicaciones científicas de 2019 a 2026. Se realizaron búsquedas exploratorias en línea en octubre de 2026.

Criterios: revisiones, metaanálisis y estudios con profesionales o estudiantes de enfermería sobre inteligencia emocional, estrés, comunicación o bienestar. Se excluyeron trabajos retractados y tesis no arbitradas.

Análisis: lectura crítica y síntesis temática de hallazgos sobre vínculos y estrés, con atención al diseño, la población, los tamaños muestrales y las limitaciones. No se registró un protocolo ni se hizo una búsqueda exhaustiva; los resultados no equivalen a una revisión sistemática.

Ética: se emplearon fuentes públicas sin datos de pacientes.

4 RESULTADOS

¿QUÉ MUESTRA LA EVIDENCIA? · KAWASHIMA (2025)

MEJORÓ LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

16 ensayos · 1.155 participantes

DME 1,76 · IC 95 %: 1,06–2,45

MEJORÓ LA COMUNICACIÓN

4 ensayos · 329 participantes

DME 2,72 · IC 95 %: 0,64–4,79

DISMINUYÓ EL ESTRÉS

4 ensayos · 312 participantes

DME −1,51 · IC 95 %: −2,96 a −0,07

Tres resultados de análisis diferentes. DME = diferencia de medias estandarizadas; las muestras no deben sumarse.

EVIDENCIA LATINOAMERICANA · SANTOS ET AL. (2024)

Ensayo piloto cruzado en Brasil (32 enfermeros líderes): se observaron mejoras en inteligencia emocional tras una intervención basada en mindfulness.



Figura 1. Los cinco componentes de Goleman (1995) y la necesidad de cuidar a quienes cuidan. Ilustración conceptual, no resultado experimental.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

Para cuidar con humanidad, también es necesario cuidar a quienes cuidan.

La evidencia revisada sugiere que el entrenamiento de inteligencia emocional puede mejorar la comunicación y contribuir a reducir el estrés, aunque existe heterogeneidad entre intervenciones y poblaciones. Los resultados proceden de investigaciones ajenas, no de una intervención propia. El ensayo piloto brasileño aporta un antecedente regional, pero sus 32 participantes limitan la generalización. Las limitaciones metodológicas y la falta de evidencia local aconsejan evaluar estas estrategias en hospitales argentinos. El bienestar del personal requiere responsabilidades compartidas: aprendizaje emocional, liderazgo, apoyo entre pares y condiciones laborales adecuadas.

6 APORTE A ENFERMERÍA

Para el cuidado, fortalecer la autoconciencia, la empatía y la comunicación puede contribuir a vínculos más humanos. Para la gestión, corresponde evaluar el bienestar del equipo, revisar la dotación de personal y prevenir riesgos psicosociales. Para la formación, integrar prácticas continuas y no actividades aisladas. Para la investigación, medir por separado inteligencia emocional, estrés y resultados asistenciales en servicios argentinos.

7 REFERENCIAS

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam.

Kawashima, T., et al. (2025). Nurse Education Today, 151, 106743. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106743

Santos, T. M., et al. (2024). Revista Latino-Americana de Enfermagem, 32, e4101. https://doi.org/10.1590/1518-8345.6548.4101

Powell, C., et al. (2024). Frontiers in Psychology, 15, 1437035. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1437035

OMS & OIT. (2022). Caring for those who care.

The Joint Commission. (2019). Quick Safety, 50.

8 RECOMENDACIONES

PERSONALES: registrar emociones difíciles del turno, identificar señales de agotamiento, pedir ayuda a tiempo y sostener una comunicación asertiva con colegas.

INSTITUCIONALES: ofrecer formación continua, evaluar periódicamente el bienestar, fortalecer el liderazgo y revisar la dotación y la carga laboral.